

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Paliperidone 3mg, 6mg, 9mg (인베가서방정, 한국안센)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1정 중 Paliperidone 3mg, 6mg, 9mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 정신분열증의 치료
- ☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**
 - 2008년 제14차 약제급여평가위원회 : 2008년 10월 30일
 - 2009년 제2차 약제급여평가위원회 : 2009년 2월 25일(재평가)
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 4월 12일(1차)
2008년 7월 21일(2차)

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “정신분열증”에 허가받은 Risperidone의 주요 활성 대사체로 하루 한번 복용이 가능하며 초기 용량 적정기간이 필요치 않은 점 등 편의성이 인정되며, 경제성 평가결과 비용 효과성이 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “정신분열증의 치료”에 허가받은 약제로, 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 다수의 약제(Risperidone, Olanzapine, Quetiapine, Aripiprazole, Ziprasidone, Amisulpride, Zotepin) 급여목록에 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 국·내외 임상 진료 지침에 따르면 정신분열증으로 진단받은 환자 치료의 급성기 및 유지기에 비정형 항정신병 약물인 Amisulpride, Olanzapine, Aripiprazole, Ziprasidone, Quetiapine, Risperidone, Zotepine 등을 1차 선택 약물로 언급하고 있음¹⁾²⁾³⁾⁴⁾.
 - 신청품은 risperidone의 주요 활성 대사체로 central dopamine D₂ 수용체와 serotonin 5-HT_{2A} 수용체에 결합하며⁵⁾ 투여 초기의 용량 적정없이 1일 1회 사용할 수 있음.
- 체계적 문헌 검토 결과 경구용 paliperidone은 위약보다 더 효과적이었으나, paliperidone에서 빈번하게 나타나는 movement disorders, 체중증가, tachycardia등은 parent compound인 risperidone에서 나타나는 유해반응과 유사함. Paliperidone은 혈장 프로락틴 농도 증가와 관련 있음. 일일 3mg 이상의 용량에서 Paliperidone이 olanzapine 10mg와 comparable한 것으로 보이며, paliperidone과 risperidone의 비교에 있어서는 paliperidone이 더 큰 장점이 있는지 혹은 단점이 있는지 결정할 만한 정보가 부족함⁶⁾.
- 정신분열증 환자에서 3건의⁷⁾⁸⁾⁹⁾ 위약대조, 6주, 이중맹검, 고정용량 단기 효과 임상 시험 결과 Paliperidone이 PANSS¹⁰⁾ 총점수 변화, CGI-S, PSP¹¹⁾ 등에서 위약과 통계적으로 유의한 차이를 보였음. 제약사 제출 2편의 Clinical Study Report 검토 결과 paliperidone은 Olanzapine과 비교시 정신분열증 환자에게 유효성 면에서 열등하지 않았으며¹²⁾, Quetiapine과 비교시 단독요법 기간동안 Paliperidone군은

Quetiapine군에 비해 PANSS 총점이 유의하게 감소하였음¹³⁾.

- Review 문헌 검토결과 Paliperidone ER은 OROS 기술을 이용하여 혈장내 peak-trough fluctuations을 최소화하여 하루한번 복용이 가능하며¹⁴⁾ 재발을 경험한 정신분열증 환자에서 재발까지 걸리는 시간이 위약과 비교시 연장된 결과를 보임¹⁵⁾. Hyperprolactinemia를 제외한 유해반응의 빈도를 볼 때 risperidone에 비해 paliperidone이 사용하기 좋은 약으로 보이나 연구 결과가 제한되어 있음¹⁶⁾.

○ 비용 효과성

- Clozapine을 제외한 first-line drug으로 사용되는 모든 비정형 항정신병약물들 (Risperidone, Olanzapine, Quetiapine, Aripiprazole, Ziprasidone, Amisulpride, Zotepin)을 대체 가능 약제로 선정하고, 대체 약제의 청구량을 고려하여 투약비용 비교대상 약제로 Risperidone, Olanzapine, Aripiprazole을 선정함.
 - Clozapine을 제외하고는 일반적으로 정신병의 목표증상과 항정신병 약물의 약리학적 특성 및 예상되는 부작용을 고려하여 약물이 선택됨¹⁷⁾.
- 투약비용 비교시, 신청품의 일일투약비용은 ■■■원(6mg기준)으로 비교대상 약제의 가중 일일투약비용인 ■■■원(WHO DDD 기준)보다 고가로 검토됨.
- Risperidone과 비교한 경제성평가자료(비용-효과 분석) 검토결과 ICER(재발예방 한 건당) 값이 ■■■원으로 제약사가 제시한 재발치료비용인 ■■■에 비해 저가에 해당하며 효과 및 비용에 영향을 미치는 변수(■■■)등의 불확실성을 고려하여 민감도 분석 결과 비용효과성이 수용 가능함.
 - Olanzapine과 비교시에는 임상적 유용성 비교 결과 효과면에서 비열등하므로, 비용최소화 분석에 의한 투약비용 비교시 신청품은 ■■■원으로 비교약제의 ■■■원 보다 저가임.

○ 재정 영향¹⁸⁾

- 신청품 도입 후 1차년도에 소요비용은 함량별 총 소요비용¹⁹⁾ 기준으로 1차년도에 ■■■원, 2~3차년도에 ■■■~■■■원에 해당함²⁰⁾. 일일상용량 6mg 함량을 기준으로 신청품 등재 후 재정증감을 추정할 때, 1차년도에 ■■■원, 2차~3차년도에 ■■■~■■■원 가량의 재정이 추가로 소요되는 것으로 보임.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국에 등재되어 있음.

○ 기타

- 외국 등재 현황 및 사용량을 예측시 12mg 함량의 미결정신청은 수용 가능한 것으로 판단됨.

Reference

- 1) Texas Implementation of Medication Algorithms(2003)
- 2) Expert Consensus Guideline(2003)
- 3) APA Practice Guideline(2004)
- 4) 국내 임상 지침서 [한국형 정신분열병 약물치료 지침서(2006)]
- 5) Hospital Pharmacy 2007; 42(7) : 637-647
- 6) Cochrane Database of Systematic Reviews 2008
- 7) Biol Psychiatry. 2007 Dec 15;62(12):1363-70
- 8) Schizophr Res. 2007 Jul;93(1-3):117-30
- 9) Schizophr Res. 2007 Feb;90(1-3):147-61
- 10) Positive and Negative Syndrome Scale
- 11) Personal and Social Performance Scale
- 12) Clinical Study Report(PALIOROS-SCH-3011;Phase3)
- 13) Clinical Study Report (R076477-SCH-3015)
- 14) Exper Opin Drug Saf. 2007 Nov;6(6):651-62.
- 15) CNS Drugs. 2007;21(5): 417-25; discussion 426-7
- 16) Am J Health Syst Pharm. 2008 Mar 1;65(5):403-13.
- 17) 제12장 정신분열병, 최신정신의학 제4판, 2005년
- 18) 제약사에서 제시한 ■■■으로 가정하고 신청품 등재 후 재정증감을 추정할 때, 등재 후 1차년도에 ■■■원, 2차~3차년도에 ■■■~■■■원 가량의 재정의 소요가 예측됨.
- 19) 3mg, 6mg, 9mg 함량 모두 포함
- 20) 제약사에서 제시한 예상사용량으로 계산함